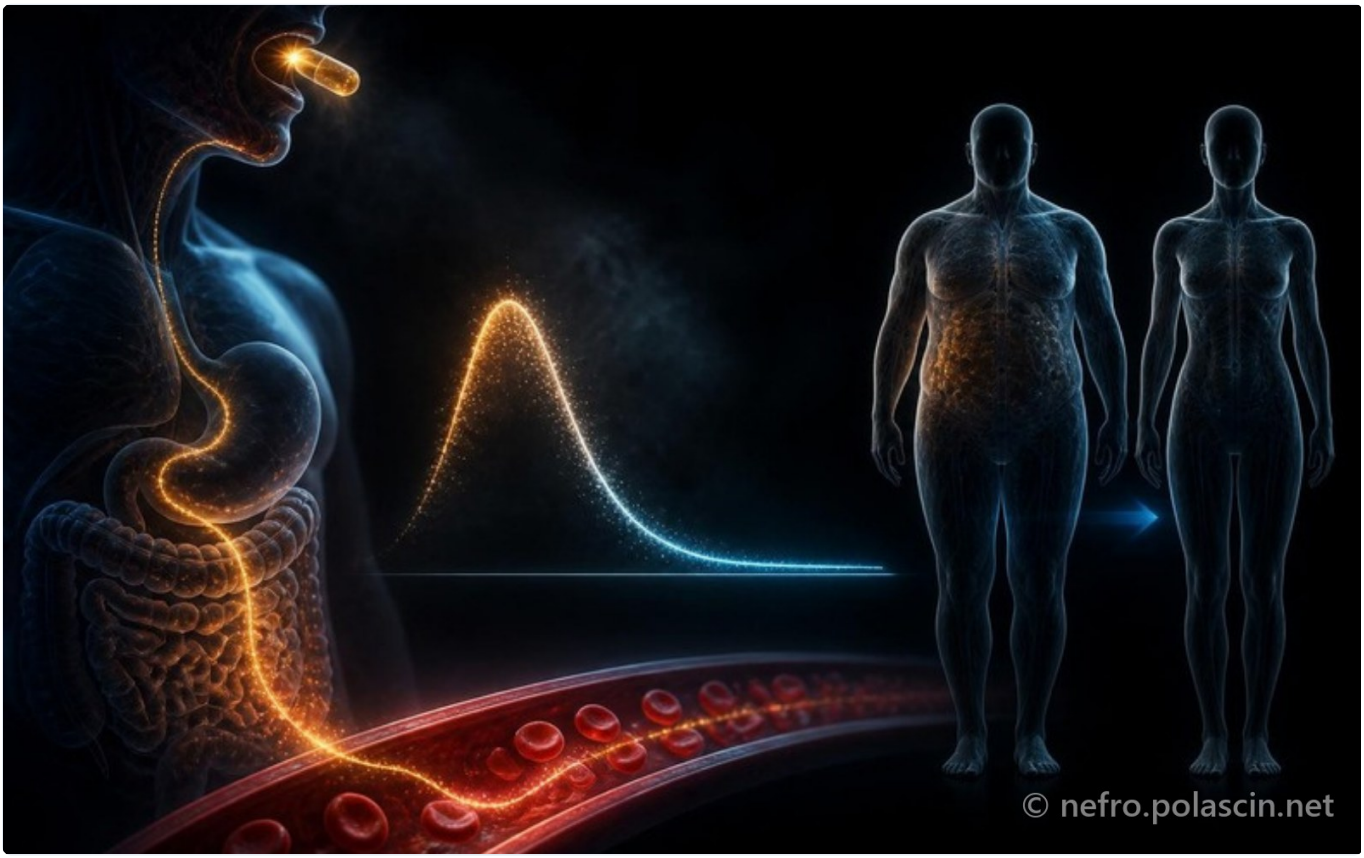
Nový perorálny agonista GLP-1 elekoglipron: výsledky fázy 2 so zlepšením HbA1c a redukciou hmotnosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 13.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Tabletka namiesto injekcie mení dostupnosť liečby – fáza 2 je však stále len medzikrok.

Elekoglipron je nový perorálny agonista receptora pre GLP-1 (malá molekula). V dvoch štúdiách fázy 2 dosiahol **klinicky významné zníženie HbA1c a glukózy** u ľudí s diabetom 2. typu a zároveň **významnú redukciu hmotnosti** u populácie s obezitou alebo nadváhou (bez diabetu 2. typu).

Prečo je to zaujímavé aj z nefrologického pohľadu

Chronická hyperglykémia a obezita sú spojené s vyšším rizikom kardiometabolických komplikácií vrátane poškodenia obličiek. Kombinovaný účinok na metabolizmus a hmotnosť by teoreticky mohol zlepšiť kardiometabolický profil vrátane rizikových faktorov kardiovaskulárnych a obličkových udalostí.

> **Dôležité upozornenie.** Ide primárne o **výsledky fázy 2**. Vplyv na dlhodobé tvrdé obličkové ciele v tejto fáze **ešte nie je preukázaný** a musia ho overiť ďalšie štúdie.

SOLSTICE (fáza 2b): diabetes 2. typu, HbA1c a hmotnosť

Do štúdie bolo zaradených **406** pacientov s diabetom 2. typu. Randomizácia zahŕňala:

- perorálne dávky elekoglipronu **5 mg, 15 mg alebo 25 mg** raz denne,
- rôzne schémy titrácie (vrátane cieľových dávok a eskalácie),
- placebo,
- a exploratórnu skupinu s perorálnym semaglutidom titrovaným na 14 mg.

Výsledky za 26 týždňov

- **HbA1c klesalo dávkovo závisle** a pri všetkých dávkach bolo zníženie väčšie ako pri placebe, približne od **0,91 %** pri 5 mg po **1,88 %** pri najvyššej dávke v schéme eskalácie.
- **Hmotnosť klesala** tiež v závislosti od dávky, približne od **2,54 %** (5 mg) po **7,61 %** pri najvyššej dávke pri eskalácii každé 2 týždne.
- Pri schéme s najvyššou dávkou dosiahol **väčší podiel pacientov aspoň 5 % redukciu hmotnosti** oproti placebu.
- Zaznamenané boli aj zlepšenia niektorých **markerov krvného tlaku a pečeňových biomarkerov**.

Bezpečnosť a tolerancia

- Nežiaduce udalosti boli v súlade s triedou GLP-1 (gastrointestinálne príznaky).
- Najčastejšie boli **nauzea, zápcha, hnačka a vracanie**.
- Časť pacientov musela liečbu ukončiť pre nežiaduce účinky, najmä pri vyšších dávkach a určitých titračných schémach.

VISTA (fáza 2): obezita alebo nadváha s komorbiditou, bez diabetu 2. typu

Do VISTA bolo zaradených **310** účastníkov s obezitou alebo nadváhou s aspoň jednou hmotnostne súvisiacou komorbiditou a **bez diabetu 2. typu**.

Dávkovanie

- týždenné titrovanie elekoglipronu v rôznych dávkach,
- vrátane režimu s titráciou každé 2 týždne (pri 75 mg),
- placebo.

Výsledky za 26 týždňov

- Priemerná redukcia telesnej hmotnosti sa pohybovala približne od **2,6 %** (najnižšia dávka) po **10,5 %** (najvyššia týždenná titrácia) oproti **0,6 %** v skupine placeba.
- Koprimárny cieľ, teda redukciu hmotnosti aspoň o 5 %, dosiahlo **88,8 %** účastníkov v skupine s elekoglipronom oproti **15,6 %** na placebe.
- Pri predĺžení na **36 týždňov** sa pri niektorých ukazovateľoch redukcia hmotnosti ďalej zväčšovala, takže po 26 týždňoch ešte nebolo zjavné plató.

Bezpečnosť

Nežiaduce udalosti boli podobného typu ako v SOLSTICE: opäť najmä gastrointestinálne príznaky.

Porovnanie s injekčnými inkretínovými terapiami

Redukcia hmotnosti s elekoglipronom je **porovnateľná s inými perorálnymi malomolekulovými agonistami GLP-1**, ale **nižšia, ako sa uvádza pri niektorých injekčných inkretínových liečbach**, ktoré znižujú hmotnosť výraznejšie.

Zdroj zdôrazňuje praktickú výhodu: **perorálne podanie** bez prísnych pravidiel užívania, ktoré môžu byť problematické pri niektorých iných perorálnych GLP-1 liekoch.

Čo z toho vyplýva do praxe a čo ešte chýba

Tieto výsledky **odôvodňujú pokračovanie** do fázy 3 (dlhšie sledovanie, širší výber populácie, relevantné kardiometabolické ciele a optimalizácia dávok a titračných schém).

Pre nefrologickú prax je kľúčové rozlišovať:

- **čo už vieme:** zlepšenia HbA1c a telesnej hmotnosti v štúdiách fázy 2,
- **čo ešte nevieme:** či sa tieto zmeny premietnu do dlhodobých **obličkových výsledkov** (predmet ďalších štúdií).

Zdroj: *Medscape, „Novel Oral GLP-1 Shows A1c and Weight Loss Benefits“ (ADA 2026; SOLSTICE a VISTA).*

medscape.com

Upozornenie: *Článok má informačný a vzdelávací charakter, sumarizuje publikované výsledky fázy 2 a nenahrádza odborné posúdenie ani aktuálne schválené indikácie a SPC.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=elekoglipron-peroralny-glp1-agonista-faza-2 · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.